

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE BÚSQUEDA DE SENSACIONES (SSS-V: 40 PARES)

Eje III: Personalidad • Modelo Psicobiológico de Marvin Zuckerman y Predisposición al Riesgo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Búsqueda de Sensaciones (Forma V - SSS-V: 40 pares forzados).
Nombre Original	Sensation Seeking Scale (Form V; Zuckerman, 1979, 1994).
Autor Original	Dr. Marvin Zuckerman (Universidad de Delaware, EE. UU.).
Adaptaciones Hispanas	Chico (2000), Univ. Rovira i Virgili; Pérez y Torrubia; España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Psicobiología. Búsqueda de sensaciones, desinhibición y riesgo.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 40 pares de elección forzada (A vs. B: opción buscadora = 1, conservadora = 0).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 15 años). Ámbito clínico, adicciones y forense.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación científica bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA DE SENSACIONES

La **Búsqueda de Sensaciones** (Zuckerman, 1979, 1994) se define como un rasgo disposicional con fuerte sustrato biológico caracterizado por la necesidad imperiosa de experimentar sensaciones y vivencias novedosas, variadas, complejas e intensas, y la disposición a asumir riesgos físicos, sociales, legales y financieros con el fin de alcanzar tales experiencias.

La Forma V es la versión estándar universal que mide cuatro factores ortogonales de 10 ítems cada uno:

- Búsqueda de Emociones y Aventura (TAS):** Deseo de participar en actividades físicamente arriesgadas o deportes extremos (velocidad, paracaidismo, escalada).
- Búsqueda de Experiencias (ES):** Deseo de estimulación mental y sensorial mediante viajes no convencionales, arte de vanguardia y estilos de vida bohemios o alternativos.
- Desinhibición (Dis):** Búsqueda de liberación social y descontrol a través de fiestas desinhibidas, consumo episódico de alcohol y multiplicidad de parejas sexuales.
- Susceptibilidad al Aburrimiento (BS):** Aversión patológica a las tareas rutinarias, entornos predecibles o personas aburridas, con agitación ansiosa ante la inactividad.

Neuroquímicamente, la búsqueda de sensaciones se vincula a concentraciones bajas de monoaminoxidasa plaquetaria (MAO-B), una elevada reactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica y un bajo tono basal de noradrenalina y serotonina.

3. FACTORES EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE LOS 40 PARES DE ELECCIÓN FORZADA

Subescala SSS-V	Pares de Ítems (40)	Nº Ítems	Foco de la Elección Buscadora de Sensaciones
1. Emoción y Aventura (TAS)	3, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 38, 40	10 ítems	Deportes extremos, velocidad y actividades de riesgo físico real.
2. Experiencias (ES)	2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 22, 26	10 ítems	Estimulación sensorial, viajes exóticos y arte transgresor.
3. Desinhibición (Dis)	1, 12, 13, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36	10 ítems	Fiestas descontroladas, alcohol social y sexualidad libre sin trabas.
4. Susceptibilidad al Aburrimiento	5, 7, 8, 15, 24, 27, 31, 34, 37, 39	10 ítems	Intolerancia a la repetición, personas rutinarias y quietud forzada.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Satisfactoria a excelente en la validación española de Chico (2000; N = 840): coeficiente alfa de Cronbach de 0.81 a 0.86 para la escala total de 40 reactivos; TAS = 0.82; ES = 0.72; Dis = 0.77; BS = 0.68. Fiabilidad test-retest $r = 0.84$ a un mes.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la solución tetrafactorial correlacionada propuesta por Zuckerman (CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.050).
Validez Concurrente	Elevada correlación con Impulsividad (Barratt BIS-11, $r = 0.54$), Extraversión (BFI-2, $r = 0.46$) y Psicopatía Subclínica (SD4, $r = 0.48$). Correlación inversa con Evitación del Daño (TCI-R, $r = -0.58$) y Conciencia/Responsabilidad ($r = -0.44$).
Validez Predictiva Clínica	Predice significativamente inicio precoz en el consumo de drogas (cannabis, cocaína), conducción temeraria, ludopatía e infracciones disciplinarias graves.
Diferencias Demográficas	Efecto robusto de edad y sexo: las puntuaciones alcanzan su pico en la adolescencia tardía (18-22 años) y declinan con la edad; los varones puntúan significativamente más alto en TAS y Dis ($d = 0.45$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 40 ítems ofrece un par de alternativas (A vs. B) excluyentes:

- **Criterio de Calificación:** La opción que indica búsqueda de sensaciones suma **1 punto**; la conservadora suma **0 puntos**.
- **Clave Oficial de Opciones Buscadoras (1 Punto):**
 - 1A, 2A, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A, 8A, 9B, 10A, 11A, 12B, 13A, 14B, 15A, 16B, 17A, 18B, 19A, 20A.
 - 21B, 22A, 23A, 24A, 25A, 26B, 27A, 28A, 29B, 30A, 31B, 32A, 33A, 34B, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A.
- **Puntuaciones de Subescala:** Suma de las opciones buscadoras elegidas en cada factor (rango **0 a 10 puntos** por subescala).
- **Puntuación Total SSS-V:** Suma de las cuatro subescalas: Puntuación Total = TAS + ES + Dis + BS (Rango: **0 a 40 puntos**).

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (0 A 40 PUNTOS)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Búsqueda	Interpretación y Manifestación Conductual
Bajo	0 a 12 puntos	Baja búsqueda / Prudente	Alta necesidad de seguridad, rutina y predictibilidad; evitación fóbica del riesgo.
Medio / Normal	13 a 22 puntos	Rango normativo / Medio	Disfrute moderado de la novedad; adecuado control inhibitorio frente a peligros.
Alto	23 a 28 puntos	Búsqueda acentuada	Atracción intensa por actividades excitantes, viajes y experiencias estimulantes.
Muy Alto / Riesgo	29 a 40 puntos	Alerta clínica (≥ 29)	Temeridad grave, impulsividad desregulada y alto riesgo de adicciones y accidentes.

CRITERIO DE ALERTA: DESINHIBICIÓN Y ABURRIMIENTO EXTREMO (Dis+BS ≥ 14):

La combinación de Desinhibición (Dis ≥ 7) y Susceptibilidad al Aburrimiento (BS ≥ 7) es el indicador más potente de adicciones químicas y comportamentales (juego patológico, policonsumo). El sujeto recurre a tóxicos como automedicación ante la intolerancia afectiva a la quietud.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE GESTIÓN CLÍNICA DEL RIESGO BASADO EN LA SSS-V

PROTOCOLO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y CANALIZACIÓN PROSOCIAL:

- **Paso 1 (Desglose de Subescalas):** Diferenciar si el impulso es de Aventura física (TAS) o de Desinhibición descontrolada (Dis).
- **Paso 2 (Canalización Saludable de la Estimulación):** No intentar forzar al paciente buscador de sensaciones a una vida monótona (fracaso garantizado); reorientar la necesidad biológica de activación hacia deportes intensos reglados (artes marciales, surf, escalada deportiva) o profesiones de alta exigencia adrenalínica (urgencias, rescate).
- **Paso 3 (Entrenamiento en Frenado Inhibitorio y Prevención de Recaídas):** Enseñar pausas de enfriamiento dopaminérgico antes de tomar decisiones impulsivas nocturnas o financieras.
- **Paso 4 (Control de Daños):** Pautar contratos conductuales para limitar el acceso a vehículos de alta cilindrada o tarjetas de crédito sin fondos de reserva.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CONDUCCIÓN TEMERARIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

Identificación: Varón de 20 años, derivado por orden judicial tras suspensión del permiso de conducir por exceso de velocidad y consumo recreativo de cannabis y MDMA en festivales de música ("si no hay marcha o velocidad siento que me muero del asco").

Evaluación Inicial SSS-V (Línea Base): Puntuación Total = **33/40 puntos** (Rango de Muy Alta Búsqueda / Alerta Clínica). Desglose: **TAS = 9/10; Dis = 9/10; BS = 8/10; ES = 7/10**. DII Impulsividad Disfuncional = percentil 90.

Plan Terapéutico: 12 sesiones de Terapia de Reducción de Daños y canalización conductual. Se le introdujo en un club deportivo de descenso en bicicleta de montaña federado (downhill), pactando tolerancia cero a tóxicos al volante como condición inexcusable.

Reevaluación a los 6 Meses: El paciente canalizó su necesidad biológica de adrenalina en el circuito deportivo federado, extinguiendo las conductas delictivas en vía pública y abandonando el consumo de estimulantes sintéticos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

BÚSQUEDA EXTREMA Y TDAH / HIPOMANÍA:

Una puntuación SSS-V ≥ 32 con marcada Susceptibilidad al Aburrimiento (BS ≥ 8) puede ser la manifestación conductual de un TDAH no diagnosticado del adulto o una fase de hipomanía bipolar (evaluar con ASRS y MDQ).

BAJA BÚSQUEDA Y FOBIAS DE EVITACIÓN:

Puntuaciones de 0 a 6 puntos no siempre reflejan prudencia; pueden enmascarar un Trastorno de Pánico con Agorafobia o un Trastorno de la Personalidad Evitativa (descartar con SCID-5-PD).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Zuckerman, M. (1979). *Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal*. Lawrence Erlbaum Associates.
2. Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. Cambridge University Press.
3. Chico, E. (2000). Búsqueda de sensaciones y habilidades sociales: Un estudio correlacional. *Psicothema*, 12(2), 229-235.
4. Pérez, J., & Torrubia, R. (1986). Fiabilidad y validez de la versión española de la Escala de Búsqueda de Sensaciones (Forma V). *Revista Latinoamericana de Psicología*, 18(1), 63-72.